

OBJECTIFS :**I-Introduction :**

- *Le cancer du col est un cancer fréquent au Maroc et dans le monde : c'est le **2^{ème} cancer de la femme**.
- *Une PEC précoce s'accompagne d'un bon pronostic.
- *Une prévention primaire est possible.
- *Un **dépistage** réalisé par le frottis cervico-utérin. Il permet de mettre en évidence non seulement des cancers infracliniques mais aussi un grand nombre de lésions précancéreuses : leur traitement permet la **prévention secondaire** du cancer invasif.
- *On note des progrès thérapeutiques (**radiothérapie...**).

II-Epidémiologie :**1-Fréquence :**

- *Il est plus fréquent dans les pays en voie de développement (car pas de dépistage systématique).
- *C'est un cancer **non hormonodépendant**.
- *Au Maroc : 80 nv-cas / 100 000 femmes/an.
- *L'âge moyen est de **45 ans actuellement** mais il survient de plus en plus à un **âge jeune**.

2-FDR :

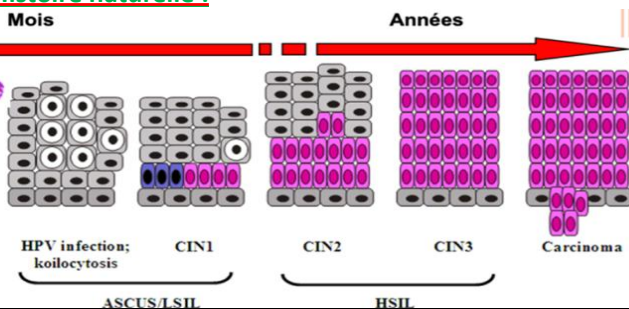
***FDR :** (même FDR de dysplasie → HPV)

- | | |
|--------------------|--|
| -Rapports précoces | -Rapports non protégés |
| -Bas niveau SE | -Partenaires multiples |
| -Multiparité | -Tabac |
| -ID | -CO : le rôle des oestroprogestatifs prête à discussion. Ils augmentent modérément le risque de kc glandulaires. |

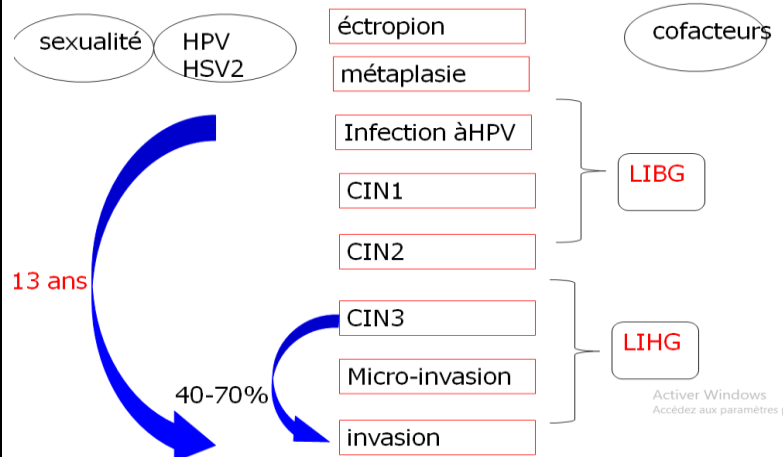
→ Ce sont les FDR d'une infection HPV

-Facteurs génétiques :

- >Cas familiaux,
- >Ag HLA 1-12 (fréquent),
- >Groupe sanguin A ++ : prédisposé à l'ADK plutôt que le carcinome épidermoïde (CE).
- Facteurs nutritionnels : graisses saturées.

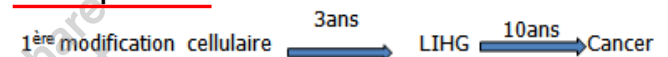
III-Histoire naturelle :

- *L'**ectropion** est défini par la présence d'épithélium cylindrique endocervical éversé sur l'exocol, ce phénomène se traduit par l'apparition d'une large zone rougeâtre entourant l'orifice externe.
- *Cet épithélium (cylindrique) est non habitué à la cavité vaginale, on aura une métaplasie pavimenteuse qui est la transformation de l'épithélium cylindrique ectopique en épithélium malpighien (phénomène physiologique de réparation).
- *En cas d'infection HPV et persistance (due à des cofacteurs liés au virus et à l'environnement) on aura une dysplasie : CIN1, CIN2 puis CIN3 → rupture de la membrane basale → Kc du col (micro-invasion puis invasion).

CANCER DU COL

- *Le passage du CIN3 à l'invasion se fait dans 40-70%.
- *La dysplasie cervicale peut évoluer soit vers la guérison, soit vers la stabilisation (60%), ou l'aggravation :

- **LIBG** : 10% s'aggrave et évolue vers LIHG puis cancer (ou directement Kc), 90% guérison spontanée qui nécessitera une surveillance.
- **LIHG** : 20-50% évolue vers un cancer (pas de place pour la surveillance → on traite).

***Classiquement :**

→ Ce qui fait qu'on a assez de temps pour dépister des lésions précancéreuses.

→ Actuellement, l'évolution est plus rapide.

IV-Anatomopathologie :**1-Macroscopie :**

***Forme exophytique** : tumeur visible au niveau du col à la pose du spéculum → bourgeonnante, polypoïde, papillaire, friable, hémorragique.

***Forme endophytique** : le col est **normal** à la pose du spéculum → tumeur se développant dans l'endocol. Il est **surtout retrouvé chez les femmes ménopausées ++** (car la zone de jonction se trouve à l'intérieur), dans ce cas la femme consulte pour des métrorragies avec col normal au spéculum, le TV trouve un col dur ++.

- **Infiltrante** : col en barillet.
- **Ulcéreuse** : cratère, base indurée, berges irrégulières.

***Mixte** : ulcéro-bourgeonnante (la tm est de taille tellement importante que les vaisseaux n'arrivent pas à irriguer toute la tumeur ce qui donne des nécroses par endroit).

***Plate** : invisible (cryptes) → ADK +++ (se développe à partir de l'endocol → dc par curetage de l'endocol ++).

2-Microscopie : Classification

2.1-Tumeurs primitives : se développe à partir d'une cellule cervicale (de l'épith pavimenteux, glandulaire, tissu musculaire).

***Épithéliales** : pavimenteux ou glandulaire → CE +++ (95%), ADK ++ (pronostic plus sombre), carcinome adénoïde basal ...

***Non épithéliales** : Leiomyosarcome, LMNH, LH...

***Autres** : Tumeur mullerienne, tumeur du sinus endodermique.

2.2-Tumeurs secondaires :

***Extension par contiguïté** : corps utérin (femme ménopausée), vessie (hématurie) rectum ...

***Métastases** : Ovaire +++, Sein +++, estomac, colon, rein, pancréas...

Chaque fois qu'on a un ADK → Essayer d'écarter la possibilité des tumeurs mammaires ou ovariennes primitives.

2.3-Selon l'invasion :

***Kc micro-invasif** : <7mm en largeur et

<5mm en profondeur (a commencé à envahir la membrane basale mais ne dépasse pas 5mm) :

- <3mm : envahissement GG <1%
- 3-5 mm : envahissement GG 4%

***Kc invasif** : > 5mm en Profondeur :

- **CE** : bien, moyen, peu ou non différencié.
- **ADK** : grade histo détermine le pronostic +++ (ADK est de plus mauvais pc).

3-Extension :

***Le kc du col est d'extension surtout locorégionale d'évolution pendant longtemps.**

3.1-Locale : le cancer naît au niveau de la zone de jonction puis il envahit :

- Le **chorion** sous-jacent
- L'**endomètre** (rare).

Le kc de l'endomètre a tendance à envahir le col, mais le kc du col envahit l'endomètre plus rarement.

3.2-Régionale :

***Vagin** : par contiguïté ou voie lymphatique → pour faire la part des 2, on cherche s'il y a du tissu sain entre le tissu tumoral cervical et vaginal

***Paramètres** : c'est la partie située de part et d'autre de l'isthme utérin à travers lequel passent l'uretère et les vaisseaux de l'utérus et du vagin. L'extension suit :

- Voie lymphatique +++
- Ou par contiguïté (compression veineuses urétérales qui donne une UHN et des douleurs lombaires dans un stade évolué),
- La voie hématogène est rare.

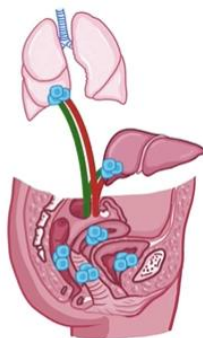
***Vessie en avant, cloison recto-vaginale et rectum en arrière** : contiguïté.

3.3-A distance :

***GG lymphatiques +++** : chaînes iliaque externes puis iliaques primitives puis GG lombo-aortiques.

***Organes** (très tardive): poumon, foie, ovaire, os, cerveau

→ **L'évolution est longtemps locorégionale +++** (avec un retentissement sévère : IR, occlusion ...)



V-Diagnostic positif :

TDD - Cancer invasif de l'exocol -

1-Circonstances de découverte :

***Métrorragie provoquées +++** (post-coïtal ou post-toilette).

***Leucorrhées pathologiques** (par surinfection de la tm).



***Douleurs pelviennes** (envahissement du plexus sacré ⇔ mauvais pc : le kc n'est pas douloureux normalement)

***Rectorragie** (envahissement du rectum)

***Hématurie** (envahissement de la vessie)

***IR, anurie** (envahissement des uretères).

***Grosse jambe** (envahissement des V. iliaques)

***Découverte fortuite** : stade précoce (tumeur de petite taille sans métrorragies) → **FCV + Colpo.**



Stade avancé

>QE : Toute femme jeune présentant des métrorragies ⇔ GEU +++ jusqu'à preuve du contraire, sinon cancer du col +++, sinon ectropion, fibrome ...

>Devant toute métrorragie provoquée il faut penser au Kc du col utérin → Spéculum +++

* Toute femme jeune présentant des leucorrhées pathologiques → Penser au Kc du col → spéculum avant l'ATB

***Devant un col apparemment sain** → **FCV.**

***Devant un col suspect** (lésions bourgeonnantes...) → **Biopsies** (pas de place ni au FCV ni à la colpo car lésion déjà localisée).

***Les métrorragies provoquées** : par un rapport: peu abondantes, indolores, voire capricieuses ou intermittentes, elles doivent faire évoquer un cancer invasif jusqu'à preuve du contraire. Un traitement symptomatique est illicite tant qu'un examen attentif, voire une colposcopie n'a pas été réalisé. Certes, de nombreuses anomalies bénignes peuvent en être la cause mais cela reste le maître symptôme;

***Les métrorragies spontanées** : en l'absence de rapport sexuel, la symptomatologie sera plus tardive et l'accroissement de la lésion finira par entraîner des métrorragies spontanées

2-Examen clinique :

Table gynécologique, vessie vide, bon éclairage

2.1-Speculum :

***Masse bourgeonnante, infiltration, ulcération +++**,

***Parfois rougeur et surface irrégulière avec saignement au contact, leucoplasie.**

* **Dans les formes asymptomatiques, le col apparaît normal ou ne présente qu'une zone rouge d'apparence banale** → analyser la zone de jonction → **colpo + biopsie**

2.2-TV :

*Analyse l'induration et son étendue

*Dépiste le saignement au contact, le volume et la mobilité du col,

*Réalise un bilan d'extension : CDS, parois vaginales, utérosacrés, utérus, annexes.

2.3-TR avec palper abdominal : pour apprécier la présence d'une infiltration des paramètres.

2.4-TV + TR (combiné) : Recherche d'un envahissement de la cloison recto-vaginale.

2.6-Examen des seins + examen général

*Il est parfois impossible de savoir si l'infiltration des paramètres est due à la tumeur ou à une réaction inflammatoire, donc pour éliminer le processus inflammatoire on prescrit des ATB et des AINS 10 jours

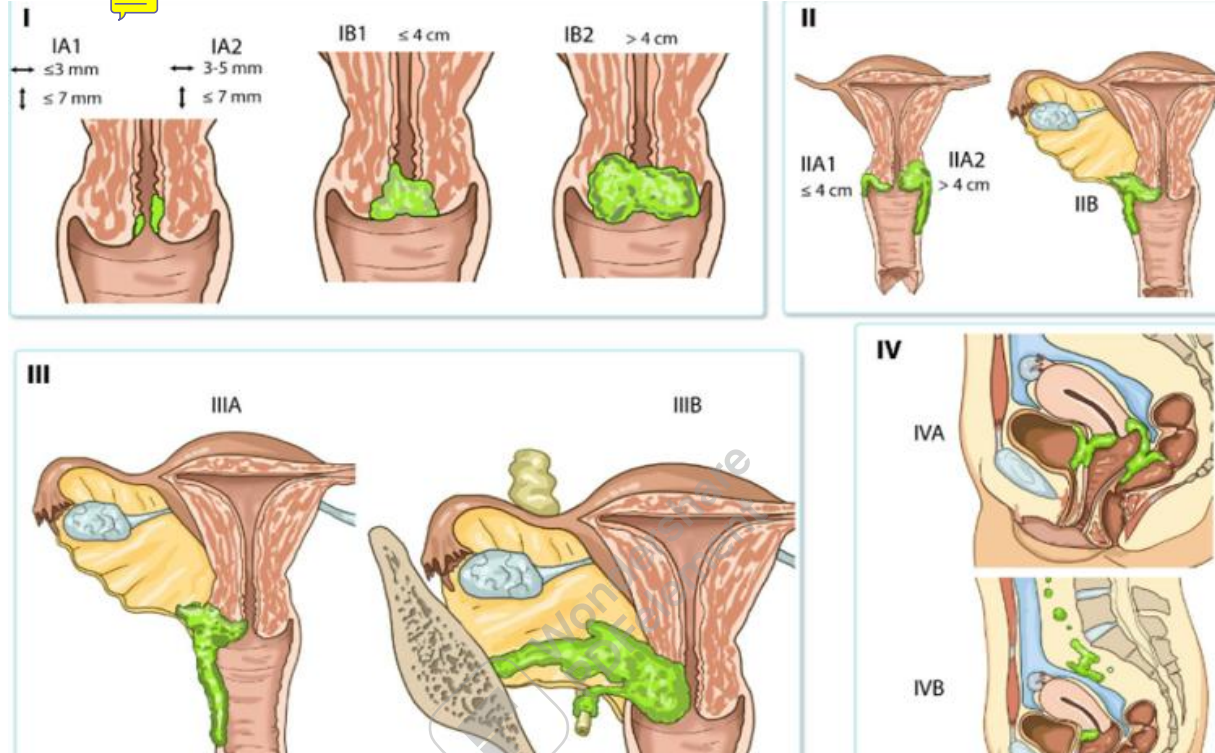
avant le geste (la tumeur du col est souvent infectée secondairement).

*L'examen se fait au bloc sous AG : les paramètres sont normalement souples (tissu graisseux), en cas d'infiltration on aura une induration des fibres

- de 1cm (1/3) ⇔ atteinte paramétriale proximale,
- de 2cm ⇔ distale
- ou 3cm ⇔ atteinte paramétriale jusqu'à la paroi pelvienne

*L'examen clinique sous anesthésie nous permet de classer le Kc du col. **La classi n'est pas à apprendre.**

3-Classification :



Stade 0 Carcinome *in situ*

FIGO

Cancer invasif

Stade I Cancer strictement limité au col utérin

Stade Ia Cancer préclinique (asymptomatique -> micro-invasif)

Ia1 profondeur d'invasion ≤ 3 mm } Largeur < 7mm
Ia2 Profondeur d'invasion > 3 à 5 mm.

Stade Ib profondeur d'invasion > 5 mm, largeur ≥ 7mm

Ib1 Lésions ≤ 4 cm (« petit col ») -> chirurgie possible.
Ib2 Lésions > 4 cm (« grand col ») -> chirurgie impossible.

Stade II extension au-delà du col, 1/3 inf vagin, paroi pelvienne

IIa 2/3 Sup du vagin
IIb paramètres proximal ou distal

Stade III

IIIa 1/3 inf du vagin
IIIb paramètre: la paroi pelvienne, hydronéphrose, rein muet

Stade IV

IVa Extension : vessie, rectum
IVb métastase à distance

Classification FIGO (2014)

Stade I

Le carcinome de stade I est strictement limité au col utérin.

- Stade IA : cancer invasif identifiable par examen microscopique uniquement. L'invasion mesurée ne dépasse pas 5 mm en profondeur et 7 mm en largeur.
- Stade IA1 : l'invasion mesurée ne dépasse pas 3 mm en profondeur et 7 mm en largeur.
- Stade IA2 : l'invasion mesurée est comprise entre 3 et 5 mm en profondeur, et ne dépasse pas 7 mm en largeur.
- Stade IB : soit les lésions sont cliniques (visibles) mais limitées au col, soit elles sont histologiques mais plus importantes que dans le stade IA2. Toute lésion visible est classée cancer de stade IB.
- Stade IB1 : lésions ne dépassant pas 4 cm de plus grand axe.
- Stade IB2 : lésions de taille supérieure à 4 cm de plus grand axe.

Stade II

Le carcinome de stade II s'étend au-delà de l'utérus, mais sans atteindre les parois pelviennes, ni le tiers inférieur du vagin.

- Stade IIA : pas d'envahissement des paramètres.
- Stade IIA1 : lésion clinique de taille ne dépassant pas 4 cm.
- Stade IIA2 : lésion clinique de taille supérieure à 4 cm.
- Stade IIB : invasion des paramètres.

Stade III

Tumeur touchant le tiers inférieur du vagin (IIIA), ou étendue à la paroi pelvienne, ou provoquant une hydronéphrose ou un rein muet (IIIB).

Une tumeur avec des métastases ganglionnaires régionales est classée IIB par exemple.

Stade IV

Tumeur étendue au-delà du petit bassin ou envahissant la vessie et/ou le rectum. Une tumeur avec des métastases ganglionnaires à distance ou des métastases vitales est classée stade IV.

Pas d'indications à la chirurgie -> chimio-radiothérapie.

FIGO 2014

4-Paraclinique :

Biopsie → étude anapath → Confirmation du diagnostic :

*Il faut préciser :

- Le type histologique,
- Le degré d'invasion,
- L'IHC pour établir un dc différentiel d'une origine de l'endomètre vers l'endocol (dans ce cas-là pas de chirurgie car c'est un stade avancé, mais si c'est un kc du col la chirurgie est possible).

VI-Formes cliniques :

1-Cancer de l'endocol : 5%

***Latent** car il se développe à l'intérieur, donc pas de saignement extériorisé ni leucorrhées (car pas d'exposition aux germes du vagin).

*La sensibilité du dépistage est diminuée car le **plvmt endocervical est difficile**.

***Association avec LIHG +++** : chaque fois qu'on a une LIHG on peut compléter par un curetage de l'endocol.

*Le diagnostic est **tardif** par rapport à l'exocol ⇔ pronostic sera plus mauvais.

*Le diagnostic est posé par **biopsie/colpo, curetage de l'endocol, conisation**.

*Il faut savoir que le CIS ne donne jamais de tumeur bourgeonnante. Si on a une tumeur bourgeonnante et que la biopsie monte un CIS ⇔ Discordance.
→ On refait la biopsie et on retrouve CIS, ça peut être un Kc endocervical qu'on confirme par conisation diagnostique ou curetage d'endocol → Kc d'endocol étendue à l'exocol.

2-Cancer sur col restant :

*Une patiente âgée opérée pour un fibrome (hystérectomie +++):

-Elle peut être soit totale (idéale, en 1^{ère} intention) ou subtotale (plus simple).

*Dans ce dernier cas on laisse le col utérin, mais il y a un **risque de faire un cancer sur le col restant** +++ : c'est un cancer de **très mauvais pronostic** car envahissement rapide de la cloison recto-vaginale, il est en plus difficile à traiter (difficile à repérer le col restant par la chirurgie).

*L'hystérectomie subtotale est surtout indiquée chez les femmes âgées célibataires (pas de rapports) ou les femmes faisant le dépistage avec FCV toujours normal.

→ **Avant toute hystérectomie : FCV +++**

*Le diagnostic est tardif avec difficulté thérapeutique.

→ **Limiter les hystérectomies subtotaux et surveiller par FCV +++**

3-Cancer du col + grossesse :

*Il représente 97% des cancers gynéco associés à la grossesse.

→ **Problème thérapeutique +++**

*La grossesse n'a aucun retentissement le cancer mais ce dernier peut retentir sur la grossesse : RPM, prématurité surtout induite, dystocie cervicale (VB rarement acceptée) + effets secondaires du traitement.

*La grossesse n'est pas un **moment idéal pour le dépistage** → Mais il faut saisir l'occasion : **Speculum systématique + FCV** (surtout si la patiente n'a pas fait de FCV il y a plus de 3 ans).

VII-Diagnostic différentiel :

*Devant une lésion bourgeonnante au niveau du col au spéculum, on pense à :

-Tb du col ++, -Chancre syphilitique,

-Fibrome du col,

-Gros œuf de Naboth : kyste muqueux qui se développe au niveau du col de l'utérus

-Endométriose : localisation inhabituelle de l'endomètre au nv du col, vagin, trompe, narines, poumons, ...

VIII-Bilan pré-thérapeutique :

1-Bilan d'extension : (permet de stadifier : reclasser)

***Écho pelvienne endovaginale, endorectale** : taille tumorale annexes, vessie, rectum.

***Radio poumon systématique**.

***Écho abdominale (foie) systématique**.

***UIV : 3 intérêts**

-Retentissement urétéral, reins, plancher vésical → permet la classification.

-Chirurgie : écarter une duplicité urétérale (si c'est le cas il ne faut pas réséquer l'uretère fonctionnel).

-Radiothérapie : rein pelvien (si c'est le cas : risque d'IR).

***IRM pelvienne +++ (examen de 1^{ère} intention)** :

-Evaluation précise du stade FIGO, il est plus performant sous anesthésie pour l'évaluation de l'extension aux paramètres → Volume tm, invasion, envahissement de l'endocol et du corps utérin, étude du haut appareil urinaire.

-Extension aux paramètres +++ : au moins identique à l'examen clinique sous AG.

***TDM** (étude morphologique) :

-ADP +++ (la mise en évidence d'ADP change complètement la PEC),

-Biopsie (scannoguidée ou par coelioscopie) des ADP pour stadifier.

→ **Limite** :

-Extension aux paramètres et aux organes de voisinage,

-Méconnaître la tm primitive notamment dans les petits cancers de stade IA et IB.

***PetScann** (étude fonctionnelle : fluorodesoxyglucose) : GG pelviens + para-aortique.

→ **Systématique ≥IB2.**

***Cystoscopie**.

***Sigmoïdo-scopie**

***Lymphographie**

***Coelioscopie** :

-Ponction-biopsie : GG pelviens (≤ IB1) + para-aortiques (≥ IB2) → meilleur adaptation thérapeutique.

***Autres si signes d'appel** : scintigraphie osseuse, imagerie cérébrale, ovaire (IRM +++).

***Marqueurs tumoraux** : SCC, ACE ... non indispensable,

→ **intérêt : surveillance +++.**

2-Bilan général :

*FR, Anémie, Infection ... +/- Avis pré-anesthésique.

IX-PEC:

Ne pas retenir les détails : retenir le diagnostic, les examens complémentaires, comment confirmer le diagnostic et le bilan d'extension, ainsi que le pronostic.

1-Moyens :

1.1-Chirurgie conservatrice : conisation, trachélectomie (ablation du col +/- partie sup du vagin, les paramètres et les GG lymphatiques (élargie)).

1.2-Chirurgie radicale : laparotomie ou coelioscopie ou coelio-vaginale

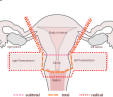
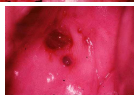
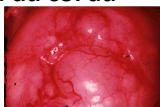
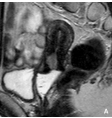
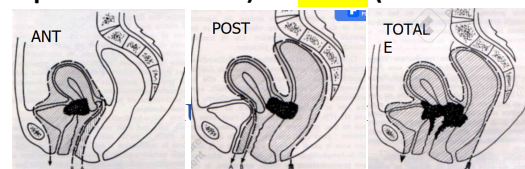
→ **Hystérectomie totale**

→ **Wertheim** (colpo-hystérectomie élargie de type 1 : par coelioscopie) avec lymphadenectomie iliaque externe.

>GG sentinelle en cours d'évaluation.

>**Transposition ovarienne** si : femme <45 ans, ≤ IB1, pas d'ADK, pas d'embolies dans les vaisseaux.

→ **Pelvectomie antérieure** (col + corps utérin + vessie) / **postérieure** (col + corps utérin + rectum) ou **totale** (+ partie du vagin).



⇒ **Complications** : Lymphocèle (curage GG), fistule urinaire, thrombophlébite (atteinte des veines lors de l'opération)...

*La transposition de l'ovaire se fait lors d'une radioTTT pelvienne, quand on déplace chirurgicalement l'ovaire, ne gouttière pariéto-colique le plus sv, afin de l'extraire du champ d'irradiation.

1.3-Radiothérapie : Externe (RTE) ou curiethérapie (endocavitaire, interstitielle)

*L'intérêt est de prévenir les récides au niveau de la tranche vaginale, traiter l'envahissement des paramètres et la chaîne iliaque externe.

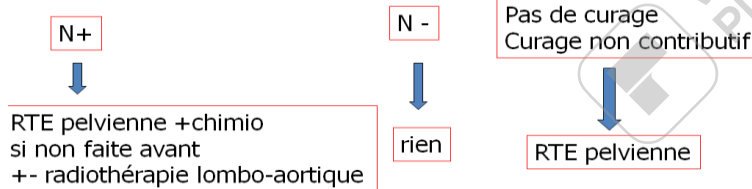
*Elle est réalisée en **pré** et/ou **post-op**.

2-Indications :

QE!!

I	Ia1	Hystérectomie totale +/- annexectomie si >45 ans.	
	Ia2	Weirthem + lymphadenectomie pelv	
	Ib1	Curiethérapie puis chirurgie après 4-6 semaines (<4 sem inflammation, >6 sem fibrose) : Weirthem + Lymphadenectomie pelvienne.	
	Ib2	Radiothérapie externe + chimiothérapie concomitante, puis curiethérapie, puis après 6 semaine : Weirthem + lymphadenectomie pelvienne.	
II + III	ADP à l'imag	Radiothérapie externe + chimio concomitante + curiethérapie	
	Pas d'ADP	Ila limité au 1/3 sup du vagin	RadioTTT externe + chimioTTT concomitante puis curiethérapie puis weirthem + curage GG pelvien.
		Ila > 1/3 du vagin, IIb, III	RadioTTT externe + chimioTTT comitante puis curiethérapie
IV	IVa	RTE + chimioTTT + TRT symptomatique +/- pelvictomie	
	IVb	RTE + chimioTTT + TRT symptomatique	

Complément thérapeutique



2.1-Cas particuliers :

2.1.1-Kc du col + grossesse :

*Il faut décider selon : le stade, l'AG, le consentement de la patiente.

-Ia1 : on attend la maturité fœtale et l'accouchement se fait par césarienne puis hystérectomie totale.

-Pour les autres stades c'est selon le trimestre :

>IMG (interruption médicale de la gro) et traitement standard au T1,

>Selon le stade et l'AG au T2,

>On attend la maturité fœtale puis césarienne et TRT standard en T3.

2.1.2-Cancer du col restant : radio-curiethérapie préférée à la radio-chirurgie.

X-Pronostic : QE

*Age : <35 ans ⇔ Valeur pc discutée : l'âge jeune est de mauvais pronostic pour certains auteurs et de bon pour d'autres. Alors que d'autres constatent que l'âge ne pourrait avoir d'influence sur le pc de la maladie.

*Terrain : anémie, AEG, rein muet

FACTEURS PRONOSTIQUES

Éléments du compte rendu anatomopathologique:

- ✓ Grade histologique
- ✓ Taille de l'infiltat en profondeur de la paroi cervicale
- ✓ Présence d'embolies vasculaires
- ✓ Limites de l'envahissement chirurgicale
- ✓ Paramètres
- ✓ Ganglions métastatiques
- ✓ Métastases à distance
- ✓ TNM - Stade FIGO

QE!!

⇒ **Complications** : cystite, rectite radique, radio-ostéonécrose ...

1.4-Chimiothérapie : de plus en plus utilisée

*Concomitante à la radiothérapie.

*Elle est utilisée dans les formes avancées : **5FU, cisplatine** +++

⇒ **Complications** : hémato, hépatique, rénale ...

1.5-Traitement symptomatique :

*Psychothérapie, radiothérapie d'hémostase (état de choc par saignement cervical), antalgique, transfusion, TRT de l'infection, dérivation urinaire, digestive.

***HPV 18** : mauvais pc car risque de récide → surveillance

***Stade FIGO** : récide à 10-20% si stade **IA-IIB**, à 20-40% si **IIB-IV**.

***Taille tumorale** : <4cm bon pronostic, >4 mauvais.

***Type histologique** : non kératinisé, ADK (mauvais pc), embolies vasculaires + lymphatiques (témoin des métastases).

***Atteinte GG** (très mauvais pronostic) :

-Survie à 5 ans de 40% en cas d'**envahissement des GG iliaque** contre 90% en absence de leur envahissement

-Survie de 5-10% en cas d'**envahissement des GG lombo-aortiques**.

XI-Surveillance :

*Surveiller les complications précoces et tardives du traitement, ainsi que les récides, et permettre la réinsertion socio-professionnelle et la réadaptation sexuelle.

*Elle se fait avec un rythme de :

-Chaque 3 mois pendant 2 ans.

-Puis : Chaque 6 mois pendant 3 ans.

-Puis : 1 fois par an.

*Elle se fait grâce à l'interrogatoire, l'examen clinique (speculum, toucher pelviens...) et des examens paracliniques :

- **Systématique** (frottis annuel +/- biopsie),

-Et d'autres guidées par la clinique (signes d'appel) : (écho hépatique, rx thorax...)

***Pas de CI à a THS**

XII-Prévention :

1-Primaire : VACCIN + DEPISTAGE

*Il existe deux vaccins anti-HPV :

-Le **Gardasil®** est un vaccin tétravalent prévenant la survenue d'une infection à 4 types différents de Papillomavirus Humains (HPV) :

2 HPV de haut risque (HPV 16 et 18) et 2 HPV de bas risque (HPV 6 et 11).

→ 0.5 ml à 0, 1 et 6 mois

-Le **Cervarix®** est un vaccin bivalent prévenant la survenue d'une infection aux HPV de haut risque de type 16 et 18

→ 0.5 ml à 0, 2 et 6 mois

*En IM au nv de la région deltoïdienne, chez les filles de 14 ans (avant le 1er rapport sexuel)

*En général, le vaccin est efficace entre 15-23 ans, au plus tard 1 an après le 1^{er} rapport sexuel.

*La vaccination ne permet pas de prévenir la totalité des cas de LIGH et du cancer du col donc le **dépistage**



Conclusion:

par FCV reste toujours indiqué chez les patientes vaccinées au même titre que les non vaccinées.

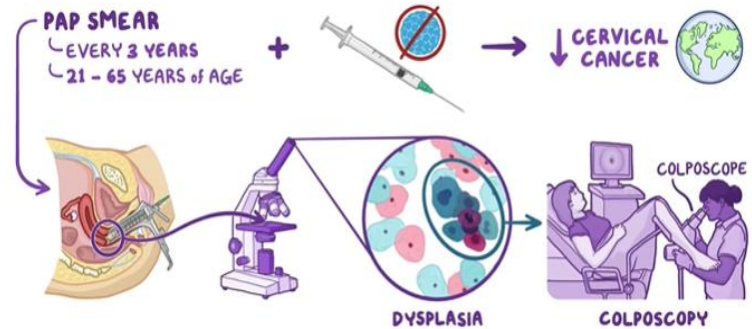
2-Secondaire : DEPISTAGE + TRT DES DYSPLASIES :

FCV 1an FCV : Normaux

puis 1FCV/ 3ans

*Il faut y penser devant toute patiente quel que soit le motif de consultation.

***Typage HPV** : dépistage primaire, en cours d'étude.



POUR LES FUTURS GYNECOS

→ QUAND FAIRE UNE LYMPHADENECTOMIE LOMBO-AORTIQUE ?

Même si on ne vous posera jamais cette question à l'IECN, vous avez généralement beaucoup de mal à comprendre ce point. Donc pour ceux que ça intéresseK il faut comprendre que dans toutes les situations dans lesquelles on sait que la patiente va bénéficier d'une irradiation pelvienne (généralement dans le cadre d'une radiochimiothérapie concomitante), un curage lombo aortique par coelioscopie préalable est indiqué pour s'assurer de l'absence d'atteinte ganglionnaire qui indiquerait d'étendre l'irradiation en plus du pelvis à l'axe lombo aortique. C'est le cas pour les tumeurs de stade à partir du stade IB2 ou bien s'il existe un ganglion pelvien métastatique identifié par le TEP TDM qui fait craindre une atteinte lombo aortique non identifiée par le TEP TDM. Ceci se justifie par le fait qu'il existe des faux négatifs du TEP TDM et qu'une radiothérapie étendue est morbide (surtout au niveau digestif). Ce curage n'a pas de rôle thérapeutique mais permet uniquement une stadification initiale de la maladie.

HPV is SEXUALLY TRANSMITTED

— RISKS HIGHEST

- DO NOT USE CONDOMS
- MULTIPLE SEXUAL PARTNERS



HPV INFECTION

CERVICAL CANCER

HPV-16

RISKS

RISK ↑

- TYPE of HPV
- LENGTH of INFECTION
- IMMUNOCOMPROMISED
- ENVIRONMENTAL FACTORS



VACCINATION

- IMMUNIZES AGAINST SEVERAL HPV TYPES LINKED TO CERVICAL CANCER



* EARLY
— SURGERY



* ADVANCED
— RADIATION & CHEMOTHERAPY

